

Calidad, indicadores, auditoría interna y PAMEC

Programa | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Medir desempeño, priorizar brechas y verificar mejora sin confundir calidad documental con cumplimiento real.

2. Alcance y condiciones de uso

IPS: evaluar PAMEC según Decreto 780 de 2016 y instrucciones aplicables. Independiente: autoevaluación y mejora local; no afirmar automáticamente que el mismo programa formal y reportes de una IPS son obligatorios.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Definir clase de prestador y alcance de las obligaciones de calidad y reporte

Definir clase de prestador y alcance de las obligaciones de calidad y reporte. Registrar la fuente aplicable para PAMEC, sin declarar no aplica a toda auditoría interna o seguridad.

2. Construir mapa de procesos y seleccionar los prioritarios por riesgos, PQR y resultados

Construir mapa de procesos y seleccionar los prioritarios por riesgos, PQR y resultados. Definir calidad esperada y línea base con datos reales.

3. Para cada indicador establecer numerador, denominador, fuente, periodo, exclusiones, respo

Para cada indicador establecer numerador, denominador, fuente, periodo, exclusiones, responsable y meta local. Si denominador es cero informar no calculable y explicar, nunca sustituir por 100%.

4. Programar auditoría con muestra, criterio y acceso autorizado

Programar auditoría con muestra, criterio y acceso autorizado. Revisar un episodio completo y condiciones físicas; anonimizaciones o acceso legítimo para historias.

5. Registrar brecha, causa y plan de mejora con responsable y plazo

Registrar brecha, causa y plan de mejora con responsable y plazo. Implementar acciones que afectan proceso o recursos, no solo actualizar un documento.

6. Volver a medir para demostrar eficacia y aprendizaje

Volver a medir para demostrar eficacia y aprendizaje. Para IPS integrar la ruta crítica de PAMEC y soportes exigibles; para independiente mantener el ciclo local y su evidencia.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Indicadores locales mensuales o trimestrales según ficha.

No inventar metas legales universales.

Reauditoría enfocada en la brecha.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Proceso y criterio	
Clase de prestador y fuente	
Numerador denominador	
Periodo y muestra	
Resultado y línea base	
Meta local	
Hallazgo	
Plan responsable plazo	
Medición posterior	
Eficacia	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Calidad y PAMEC

Decreto 780 de 2016, título de garantía de calidad, artículos 2.5.1.4.1 y siguientes; en particular 2.5.1.4.6 para IPS. Identificar obligaciones por clase de prestador, separando PAMEC formal de la mejora y autoevaluación local.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576